AZ ÉRZELEM-STRESSZ-VISELKEDÉS (ESV) MODELL INTEGRÁLT SZAKMAI KÉZIKÖNYV

Elmélet, diagnosztika és beavatkozás a funkcionális pszichológiában

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18047810

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

Budapest, 2025

Kivonat

Háttér és célkitűzés:
A modern mentálhigiénés ellátórendszer egyik legnagyobb kihívása a tüneti diagnosztika statikussága és a kliensek mindennapi működését leíró dinamikus változók közötti szakadék. Jelen kézikönyv bemutatja az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modellt, egy integrált pszichobiológiai keretrendszert, amely a mentális állapotokat nem betegségkategóriaként, hanem az idegrendszeri szabályozás, a környezeti terhelés és az adaptív válaszok kölcsönhatásaként értelmezi.

Módszertan:
Az ESV-modell egy négyváltozós algoritmus (Arousal, Protection, Hardship, Condition) segítségével 122 egyedi funkcionális állapotot (kódot) különböztet meg. A modell a neurobiológiai kutatások (különösen a talamikus gátlás és a polivagális elmélet) eredményeit ötvözi a rendszerelméleti megközelítéssel, lehetővé téve az elaprózódás (burnout) és a traumás adaptáció korai felismerését.

Alkalmazási terület és jogköri nyilatkozat:
Az ESV-modell kifejezetten a funkcionális állapotfelmérés és döntéstámogatás eszköze.

- Mit nyújt: Térképet a segítő szakemberek számára a kliens aktuális teherbíró képességének és megküzdési stratégiáinak megértéséhez.

***- Mit NEM nyújt*:** A modell és a hozzá tartozó mérőeszközök **nem minősülnek orvostechnikai eszköznek**, és nem helyettesítik a BNO (ICD) vagy DSM szerinti klinikai diagnosztikát, sem a pszichiátriai szakvizsgálatot. A modell alkalmazása nem váltja ki a szükséges orvosi vagy klinikai pszichoterápiás beavatkozást, hanem a szupportív, mentálhigiénés és önismereti folyamatokat támogatja.

Következtetés:
Az ESV-keretrendszer egy hiánypótló „közös nyelv” a segítő szakmában, amely áthidalja a szubjektív élmény és az objektív megfigyelés közötti távolságot, elősegítve a prevenciót és a célzott, személyre szabott intervenciót.

Kulcsszavak:
ESV-modell, funkcionális pszichológia, rendszerelmélet, érzelem-szabályozás, stressz-adaptáció, mentálhigiénés állapotfelmérés, döntéstámogatás, pszichobiológiai integráció.

0. Impresszum és jogi nyilatkozat

A mű címe: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell – Integrált szakmai kézikönyv
Alcím: Elmélet, diagnosztika és beavatkozás a funkcionális pszichológiában
Szerző: Ódor Antal, független kutató
Kiadás éve: 2025
Verzió: 1.0

A modell definíciója és célja

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell egy integrált **pszichobiológiai keretrendszer**, amely a mentális működést nem statikus címkék, hanem dinamikus folyamatok (érzelem-szabályozás, stresszválasz, viselkedéses adaptáció) mentén vizsgálja. A modell célja a paradigmaváltás elősegítése: a tünetközpontú megközelítés helyett a funkcionális állapotfelmérés és a folyamatalapú intervenció támogatása.

Az ESV-modell elsősorban a **mentális egészségmegőrzés, a szupportív mentálhigiéné és az önismereti munka eszköze.**

Jogi és etikai figyelmeztetés

Kérjük, a dokumentum tanulmányozása és alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

1. A szerzői kompetencia határai:
A jelen mű szerzője, Ódor Antal, **független kutatóként** definiálja tevékenységét. A szerző nem rendelkezik orvosi, klinikai szakpszichológusi vagy pszichoterapeutás működési engedéllyel. A jelen műben foglaltak a szerző többéves kutatómunkájának, rendszerelméleti elemzéseinek és empirikus megfigyeléseinek szintézisét képezik.

2. Nem helyettesíti a klinikai diagnosztikát:

Az ESV-modell diagnosztikai kódrendszere (ESV-kódok) **funkcionális állapotleíró rendszer**, nem pedig a BNO (ICD) vagy a DSM (DSM-5) szerinti hivatalos orvosi diagnózis. A kézikönyvben található mérőeszközök és protokollok nem helyettesítik a szakirányú orvosi vizsgálatot, a pszichiátriai diagnózist vagy a hivatalos klinikai terápiát.

- Súlyos mentális zavar, pszichotikus állapot vagy öngyilkossági krízis gyanúja esetén a szakember köteles a klienst a megfelelő egészségügyi ellátórendszerbe irányítani.

3. Szakmai felhasználói felelősség:

A kézikönyv kifejezetten a segítő szakmában dolgozó szakemberek (pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások, coachok, fejlesztőpedagógusok) számára készült, kiegészítő eszközként.

- Az ESV-modell eszközeit minden szakember **kizárólag a saját kompetenciahatárain belül**, saját szakmai felelősségére alkalmazhatja.

- A szerző kizár minden felelősséget a modell helytelen, szakszerűtlen vagy a kompetenciahatárokat átlépő alkalmazásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Szerzői jog és felhasználási feltételek

Ez a dokumentum és a benne foglalt szellemi tulajdon (beleértve a modelleket, ábrákat, kódrendszert és protokollokat) szerzői jogi védelem alatt áll.

Felhasználási Licenc: CC BY-NC-ND 4.0
(Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd!)

A szerző, Ódor Antal, az alábbi feltételekkel engedélyezi a mű felhasználását:

- Terápiás és szakmai használat (megengedett): A kézikönyv és a benne található eszközök (kérdőívek, protokollok) szabadon és ingyenesen felhasználhatók az egyéni vagy csoportos segítői munka, tanácsadás és terápia során.

- Oktatás és terjesztés (korlátozott): A mű szabadon megosztható szakmai közösségekben, amennyiben a szerző és a forrás egyértelműen megjelölésre kerül.

- Kereskedelmi forgalomba hozatal (tilos): Szigorúan tilos a művet vagy annak bármely részét pénzért értékesíteni. Tilos a modellre épülő fizetős képzéseket, tanfolyamokat, workshopokat szervezni vagy a módszertant saját szellemi termékként franchise rendszerben értékesíteni a szerző kifejezett, írásos engedélye nélkül.

- Módosítás (tilos): A mű integritásának megőrzése érdekében tilos a szöveg, a modell struktúrájának vagy a diagnosztikai kódrendszernek a megváltoztatása, átdolgozása.

Minden, a fentiektől eltérő felhasználás (pl. kutatási együttműködés, hivatalos oktatási akkreditáció) kizárólag a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Kapcsolat: odor.antal@mozgasjavito.com
Copyright © 2025 Ódor Antal. Minden jog fenntartva.

I. fejezet: Elméleti alapvetés

„A pszichológia a trauma feldolgozásában hajlamos leegyszerűsítő, 'tiszta' narratívákban gondolkodni, miközben a valós élmény gyakran kaotikus, ellentmondásos és a józan ész számára felfoghatatlan." - Ódor A.

1.1. Bevezetés: A statikus diagnosztika válsága és a funkcionális szemlélet szükségessége

A modern viselkedéstudomány és a mentálhigiénés ellátórendszer évtizedekig a **lineáris oksági modellek** („Top-Down" vezérlés) dominanciája alatt működött. Ez a megközelítés azt feltételezi, hogy a kogníció képes lineárisan szabályozni az emóciót és a viselkedést, a diagnosztika feladata pedig a tünetek statikus címkékbe (BNO/DSM kategóriák) rendezése.

A 2025-ös év kutatási eredményei és a terepi tapasztalatok azonban rámutatnak ezen paradigma korlátaira. Krízisállapotban, tartós stressz alatt vagy traumás fixáció esetén a lineáris szabályozás összeomlik. A „tiszta" diagnosztikai kategóriák gyakran nem fedik le az egyén szubjektív szenvedését, különösen az olyan diffúz, nehezen megfogható állapotokat, mint a *traumatikus ambivalencia* vagy az *elaprózódás* (burnout) korai fázisa.

A lineáris modell vs. rendszerszemlélet

A hagyományos modellek hiányossága, hogy a mentális szenvedést gyakran izolált hibaként kezelik. Ezzel szemben az ESV-modell (Érzelem-Stressz-Viselkedés) egy **cirkuláris (körkörös) kauzalitásra** épülő keretrendszer.

- *A probléma gyökere:* Nem egy külső esemény önmagában, és nem is egy „elromlott" agyi funkció.

- *A funkcionális valóság:* Egy dinamikus, önmagát szabályozó visszacsatolási hurok (*feedback loop*), ahol az érzelmi válasz, a stresszreakció és a viselkedés egymást erősítve tart fenn egy állapotot - akár a kiváltó ok megszűnése után is.

Ez a szemléletváltás a **funkcionális pszichológia** alapja: nem azt kérdezzük, hogy „mi a baj" (címke), hanem azt, hogy „hogyan működik a rendszer" (folyamat). A cél az, hogy a szenvedés „piszkos", ellentmondásos valósága mögött felismerjük a rejtett, de szigorú logikával működő szerkezetet.

1.2. A modell változói

Az ESV-keretrendszer az emberi működést nem statikus állapotokként, hanem változók dinamikus kölcsönhatásaként írja le. A modell négy alappillére (A, P, H, C) teszi mérhetővé és modellezhetővé a belső folyamatokat.

Ezen változók definíciója a korábbi publikációkban ismertetett E-S-V (Érzelem-Stressz-Viselkedés) triád matematikai és funkcionális kiterjesztése.

A(t) - Arousal: A belső feszültség

(Származtatása: Az Érzelem (E) és Stressz (S) komponensek energetikai összege)

Az Arousal nem csupán az idegrendszeri éberséget jelöli, hanem a rendszerben lévő **teljes energetikai töltöttséget**. Ez a változó mutatja meg a belső nyomás mértékét egy adott időpillanatban.

- *Funkciója:* Jelzőrendszer. Megmutatja az én és a külvilág közötti viszony zavarát.

- *Megjelenése:* Lehet fiziológiai (szívdobogás, izomfeszülés) és pszichés (szorongás, düh, szégyen, belső agitáltság).

- *Dinamikája:* Ha az Arousal szintje meghaladja az egyén toleranciaküszöbét (ablakát), a rendszer kényszerpályára lép, és bekapcsolja a védelmi mechanizmusokat.

P(t) – Protection: A szabályozás

(Származtatása: A Viselkedés (V) funkcionális értelmezése)

A modell legkritikusabb eleme. A Protection (Védelem) minden olyan viselkedéses vagy kognitív választ jelöl, amelynek célja az Arousal (A) csökkentése vagy elviselhető szinten tartása.

- *Lényege:* Nem a külső célok elérése, hanem a belső homeosztázis (vagy annak illúziójának) fenntartása.

- *Formái:* Lehet adaptív (pl. sport, alkotás) vagy maladaptív (pl. szerhasználat, elkerülés, kényszercselekvések, agresszió).

- *A „Működő Én" válasza:* A P(t) gyakran automatikus, tudattalanul aktiválódó protokoll, amely felülírja a racionális döntéshozatalt (ez a „*tudom, de nem tudom megtenni"* jelenség alapja).

H(t) – Hardship: A környezeti terhelés, stresszérzékelés

(Származtatása: Az Exogén Mező / Omega változó)

A Hardship a rendszerre nehezedő külső nyomást reprezentálja. Ez az a környezeti kontextus, amelyben az egyénnek működnie kell.

- *Összetevői:* Aktuális életesemények (munkahelyi stressz, konfliktusok), társadalmi elvárások, vagy a CBER-modellben leírt „Külső Programok" (családi szkriptek, szociális nyomás).

- *Szerepe:* A Hardship a „trigger", a katalizátor, amely próbára teszi a rendszer kapacitását. Önmagában nem determinál, de kontextust ad az Arousal emelkedéséhez.

C(t) – Condition: A szomatikus válasz és alapállapot

(Származtatása: A biológiai és idegrendszeri bázis)

A Condition az egyén **aktuális teherbíró képességét** és fiziológiai állapotát írja le. Ez a „tartály”, amelynek meg kell tartania a feszültséget.

- Elemei: Az idegrendszeri szabályozottság szintje (neurobiológiai háttér), a fizikai egészség, az alvásminőség és a korábbi traumák szomatikus lenyomatai („*A test mindent számontart”*).

- Jelentősége: Ha a C(t) értéke alacsony (pl. kimerültség, betegség vagy krónikus trauma miatt), a rendszer már minimális Hardship (H) hatására is extrém Arousal (A) választ ad, aktiválva a maladaptív Protection (P) mechanizmusokat.

Szintézis:

Az ESV-modell e négy változó interakciójaként írja le a mentális állapotokat. A szenvedés nem más, mint ezen változók diszfunkcionális egyensúlya (pl. magas Arousal + gyenge Condition + maladaptív Protection), amely idővel önfenntartó **kényszerhurokká** (Compulsion Loop) merevedik.

1.3. Neurobiológiai háttér

Az ESV-modell nem a levegőben lógó elmélet, hanem szorosan illeszkedik a modern idegtudomány azon eredményeihez, amelyek a stresszválasz tartósságát és a szabályozó rendszerek hierarchiáját vizsgálják. A modell változói (különösen a *Protection* és a *Condition*) megfeleltethetők konkrét idegrendszeri struktúráknak.

A kényszerhurok biológiai alapja: A talamikus „beragadás”

(Acsády László és a KOKI Talamusz Kutatócsoportjának eredményei alapján)

Az ESV-modell egyik központi állítása, hogy a stresszre adott válasz (Arousal) nem múlik el azonnal a kiváltó ok (Hardship) megszűnésével, hanem önfenntartó körfolyamattá válhat. Ezt a pszichológiai megfigyelést támasztják alá a KOKI legfrissebb kutatásai (Bíró, Jász, Acsády et al., 2024-2025).

A kutatók kimutatták, hogy a **paraventricularis talamusz (PVT)** kulcsszerepet játszik a fenyegetettség érzékelésében. Míg korábban a talamuszt egyszerű átkapcsoló állomásnak hitték, mára bizonyított, hogy a PVT specifikus idegsejtjei (calretinin-pozitív neuronok) stressz hatására nemcsak aktiválódnak, hanem *tartósan aktív állapotban maradnak* az esemény után is.

Az ESV-relevancia:

- Ez a biológiai mechanizmus magyarázza a **Pszichés Kényszerhurok** (Compulsion Loop) fiziológiai alapját.

- A „beragadt” talamikus aktivitás folyamatosan „veszélyt” jelez az agykéregnek (Prefrontális Kéreg) és az amygdalának, akkor is, ha a külső veszély már elmúlt.

- Ez kényszeríti a rendszert a **Protection (P)** mechanizmusok (pl. kényszercselekvések, túlgondolás, szerhasználat) folyamatos fenntartására. A hurok tehát nem „akaratgyengeség”, hanem egy idegrendszeri rögzülési folyamat.

A biztonság és lefagyás élettana: A polivagális elmélet

(Stephen Porges munkássága alapján)

Míg a talamusz a „beragadást” (magas Arousal) magyarázza, addig a rendszer teherbírását és a szabályozás szintjeit (Condition) Stephen Porges Polivagális elmélete írja le a legpontosabban. Az ESV-modell ezt a hierarchiát használja a diagnosztikai kódok értelmezéséhez.

A modell a **neurocepció** (tudattalan veszélyérzékelés) fogalmára építve három állapotot különböztet meg, amelyek megfelelnek az ESV-zónáknak:

1. Ventrális vágusz (Szociális elköteleződés): Ez az ESV szerinti „Zöld Zóna” (Optimális Arousal, Adaptív Protection). Itt az idegrendszer képes a kapcsolódásra és a regenerációra.

2. Szimpatikus aktiváció (Harc/Menekülés): Ez a magas Arousal zóna. A szervezet mobilizál, a Protection (P) aktívvá, gyakran agresszívvá vagy menekülővé válik.

3. Dorszális vágusz (Lefagyás/Shutdown): Ez a rendszer összeomlása. Ha a Hardship (H) meghaladja a megküzdési kapacitást, a szervezet „kikapcsol”. Ez az ESV-modellben a **Lefagyás-tengely** alapja.

1.4. A Rendszerdinamika: Hogyan mozog a spirál?

A változók (A, P, H, C) nem statikusan állnak egymás mellett, hanem folyamatos mozgásban vannak. A szerző publikációiban („Ambivalencia”, „Elaprózódás”) leírt jelenségek az ESV-modellben két alapvető dinamikai tengely mentén rendeződnek.

A. A „Lefagyás-tengely”

(A traumatikus ambivalencia dinamikája)

Ez az állapot akkor következik be, amikor a környezeti terhelés (H) hirtelen vagy tartósan meghaladja a rendelkezésre álló védelmi kapacitást (P), és a rendszer nem tudja csökkenteni a belső feszültséget (A).

- *A Képlet:* $H(t) > P(t) \rightarrow C(t)$ összeomlás

- *A Pszichodinamika:* Ez a „t*udom, de nem tudom megtenni”* állapota. A kognitív funkciók épek lehetnek (a kliens érti a helyzetet, látja a megoldást), de a cselekvési képesség blokkolódik. A rendszer a védelem érdekében a dorszális vágusz (Lefagyás) állapotba zuhan.

- *Tünettan:* Motivációvesztés, érzelmi bénultság, disszociáció, döntésképtelenség. Fontos: Ez nem depresszió (bár tünetileg hasonlít), hanem egy funkcionális védekezés a rendszer túlhevülése ellen. Az ambivalencia itt nem döntési nehézség, hanem a rendszer leállása két ellentétes parancs (menekülj vs. maradj) között.

B. A „magas funkciójú paradoxon”

(Az Elaprózódás és Burnout dinamikája)

Ez a modern kor legjellemzőbb, nehezebben felismerhető kórképe, amelyet az „Elaprózódás” című tanulmány tárgyal. A rendszer látszólag jól működik, a teljesítmény magas, de a belső „költség” fenntarthatatlan.

- *A képlet:* Magas P(t) elrejti a magas A(t)-t → C(t) lassú eróziója

- *A pszichodinamika:* Az egyén „túlműködi” a stresszt. A Protection (P) itt nem lefagyás, hanem *hiperaktivitás* (munkamánia, megfelelési kényszer, perfekcionizmus, folyamatos agyalás). A környezet (H) nem lát problémát, mert a viselkedés adaptívnak, sőt, produktívnak tűnik.

- *Az elaprózódás:* Mivel a belső feszültség (A) nem csökken, csak elfedésre kerül, a szomatikus tartály (C) lassan, de biztosan kiürül. A figyelem fragmentálódik, a fókusz elveszik, a cselekvések kényszeressé válnak.

- *A végkifejlet:* Ez vezet a hirtelen, előjel nélküli összeomláshoz (infarktus, pánikroham, hirtelen totális kiégés). Az ESV diagnózisa szerint ez az állapot az **„Integritásvesztés”** előszobája: a rendszer elemei (amit érzek vs. amit teszek) elszakadnak egymástól.

II. fejezet: Operációs kézikönyv

Mérésmódszertan és algoritmizálás

2.1. A mérőeszköz specifikációja (ESV-25 Inventory)

Az állapotfelmérés alapját az ESV-25 kérdőív képezi, amely négy funkcionális dimenzió (A, P, H, C) mentén vizsgálja a pszichés működés dinamikáját. A skála a nemzetközi gyakorlatban validált klinikai mérőeszközök (STAI, DERS, PSS, PHQ-15) rövidített, faktoranalízissel szűrt és a magyar nyelvi környezetre adaptált itemeiből épül fel.

A mérés célja nem a személyiség statikus jellemzése, hanem az **aktuális működési állapot (State)** rögzítése.

A változók operacionalizálása:

Változó	Teljes Megnevezés	Bázis Skála (Eredeti)	Itemek száma	Skálatípus	Méréstartomány (Min-Max)
A(t)	**Arousal** (Belső Feszültség)	STAI (State-Trait Anxiety)	6 db	Likert (1-5)	6 – 30 pont
P(t)	**Protection** (Szabályozás)	DERS (Emotion Regulation)	6 db	Likert (1-5)	6 – 30 pont
H(t)	**Hardship** (Terhelés)	PSS (Perceived	4 db	Likert (1-5)	4 – 20 pont

		Stress)			
C(t)	**Condition** (Szomatikus Bázis)	PHQ-15 (Somatic Symptoms)	5 db	Súlyozott (0-2)	0 – 10 pont

2.2. Számítási Metodika és Normalizálás

A nyers pontszámok önmagukban nehezen értelmezhetők, ezért azokat egy [0, 1] intervallumra normalizált indexekké alakítjuk át. Ez teszi lehetővé a különböző dimenziók összehasonlítását és a kódképzést.

2.2.1. Index-számítási Képletek

A nyers pontszámokat (x) minden tengelyen a 0 és 1 közötti tartományra normalizáljuk az összehasonlíthatóság érdekében.

1. Arousal Index (I_A) – Belső feszültség

A belső feszültség egyenes arányban nő a pontszámmal. Mivel a maximálisan elérhető pontszám 30, a képlet a következő:

index = nyers pontszám / 30

Értelmezés: Minél közelebb van az eredmény az 1-hez, annál magasabb a belső feszültség szintje.

2. Protection Index (I_P) – A szabályozás (inverz logika)

Ez a modell matematikai különlegessége. Mivel az eredeti DERS skála a szabályozási nehézséget méri (tehát a magas pontszám rossz szabályozást jelent), az ESV-modellben ezt megfordítjuk, hogy a **védelmi kapacitást** kapjuk meg:

index = 1 – (nyers pontszám / 30)

Értelmezés:

- Ha a nyers pontszám magas (sok nehézség), akkor az index alacsony (gyenge védelem).
- Ha a nyers pontszám alacsony (kevés nehézség), akkor az index magas (erős védelem).

3. Hardship Index (I_H) – Környezeti terhelés (stresszérzékelés)

A kérdőív alapján a maximális terhelés pontszáma 20 lehet. A képlet arányosítja a kapott értéket.

index = nyers pontszám / 20

Értelmezés: Ez a mutató jelzi, hogy a kliens szubjektíven mekkorának éli meg a rá nehezedő külső nyomást. A magas érték (közel az 1-hez) extrém környezeti stresszt jelez.

4. Condition Index (I_C) – Testi Állapot
A szomatikus tünetek súlyozott értéke maximum 10 pont lehet:

Index = Nyers pontszám / 10

Értelmezés: Ez az érték a „biológiai vészjelző". Megmutatja, mennyire telítődött a szervezet a stresszel. A magas érték (közel az 1-hez) a pszichoszomatikus tünetek elhatalmasodását és a fizikai teherbírás csökkenését jelzi.

2.3. Kódképzési algoritmus

A kapott Index-értékeket egy rögzített küszöbérték-rendszer (Cut-off points) alapján soroljuk be az 1-től 4-ig terjedő funkcionális állapotkategóriákba. Ez az algoritmus határozza meg a végső 4 jegyű ESV-állapotkódot.

A zónák definíciója:

értéktartomány (index)	kód	zóna megnevezése	funkcionális jelentés	színkód
0.00 – 0.30	**1**	**low** (alacsony)	nyugalmi állapot / inaktivitás / stabilitás	zöld
0.31 – 0.60	**2**	**normal** (normál)	adaptív működés / egyensúlyi zóna / aktív megküzdés	sárga
0.61 – 0.80	**3**	**elevated** (emelkedett)	fokozott terhelés / túlműködés / dekompenzáció gyanúja	narancs
0.81 – 1.00	**4**	**critical** (kritikus)	Rendszerszintű zavar / Összeomlás / Krízis	vörös

Megjegyzés: A P(t) tengelyen a magas érték (3-as, 4-es) pozitív jelentésű (erős védelmet jelez), míg a többi tengelyen (A, H, C) a magas érték patológiát vagy terhelést jelez. Ezt az értelmezésnél figyelembe kell venni.

2.4. Az eredmény: A funkcionális profil

A funkcionális profilok szűkítése: Miért 122 a 256 helyett?

A modell matematikai struktúrája a 4 változó (A, P, H, C) 4 szintű skálázásából adódóan elméletileg 256 lehetséges kombinációt (permutációt) tesz lehetővé. A mentálhigiénés gyakorlat és a rendszerelméleti logika alapján azonban ez a szám 122 releváns működési mintázatra (profilra) szűkült.

A szűkítés három szakmai szűrő alkalmazásának eredménye:

1. Fiziológiai inkompatibilitás:
Bizonyos elméleti kombinációk a gyakorlatban nem, vagy csak kivételes esetben fordulnak elő, mivel az emberi szervezet működési logikájával ellentétesek.

- *Példa:* Ha az *Arousal* (A) és a *Protection* (P) is minimális szinten van (nyugalom és inaktivitás), a szervezet pszichés okból nem produkál kritikus szintű testi összeomlást (*Condition* = 4). Az ilyen extrém esetek nem tartoznak a funkcionális állapotfelmérés körébe, mivel azok vélhetően független organikus eredetűek.

2. A dominancia elve (összevonások):
Kritikus állapotokban (különösen a 4-es szintű értékeknél) egyetlen változó hatása annyira dominánssá válhat, hogy a többi változó finomhangolása már nem változtat érdemben a beavatkozási stratégián.

- *Példa:* Amennyiben a belső feszültség (*Arousal*) eléri a kritikus szintet (4), és hiányzik a szabályozás (*Protection* = 1), a rendszer „Vészhelyzeti" állapotba kerül. Ebben a helyzetben a külső terhelés (*Hardship*) mértéke másodlagos, mivel az elsődleges feladat minden esetben a stabilizálás. Az ilyen profilok egy közös állapotleíró kategóriába kerülnek.

3. A szabályozás (Protection) elfedő hatása:
A magas szintű szabályozási kapacitás (P=3 vagy 4) képes ideiglenesen elfedni vagy kompenzálni a belső feszültségeket és a kezdeti testi jelzéseket.

- *Példa:* Erős kontroll mellett ritkábban találkozunk köztes, bizonytalan állapotokkal. A rendszer vagy sikeresen kompenzál (tünetmentesnek tűnik), vagy a terhelés hatására hirtelen billen át a dekompenzált állapotba. Emiatt a magas szabályozási tartományban kevesebb, de élesebben elkülönülő profil létezik.

Összegzés:
A kézikönyvben szereplő 122 állapotkód tehát a valós életben előforduló, funkcionálisan értelmezhető és specifikus intervenciót igénylő mintázatokat fedi le.

Formátum: [A - P - H - C]

Példaelemzés:
Ha a számított kód: **3 - 1 - 2 - 4**

- **A=3 (Emelkedett Arousal):** A kliens belső feszültsége magas, szorong vagy dühös.

- **P=1 (Alacsony Protection):** A szabályozási kapacitása összeomlott vagy fejletlen. Nincs belső „fék".

- H=2 (Normál Hardship): A környezeti terhelés (stresszérzékelés) átlagos. (Ez a legveszélyesebb: a kliens „belülről” ég, nem a külső nyomás miatt).

- C=4 (Kritikus Condition): A test súlyos tünetekkel (pl. pánikroham, fájdalom) reagál.

Konklúzió (példa): Súlyos szomatizáció. (A részletes leírásokat a III. fejezet tartalmazza).

III. fejezet: Funkcionális állapotleíró kézikönyv

A fejezet célja, hogy a diagnosztikai mérés során kapott négyjegyű ESV-kódot (A-P-H-C) lefordítsa a szakember számára értelmezhető működési mintázattá. A leírások nem orvosi diagnózisok, hanem a pszichés rendszer pillanatnyi dinamikáját, teherbíró képességét és kockázatait térképezik fel.

A kódok értelmezési kulcsa:

- A (Arousal): 1-4 (alacsonytól a kritikusig) – *Ez határozza meg a főcsoportot.*

- P (Protection): 1-4 (gyengétől a kiválóig) – *Ez határozza meg a megküzdési kapacitást.*

- H (Hardship): 1-4 (környezeti terhelés, stresszérzékelés).

- C (Condition): 1-4 (testi állapot).

3.1. Az 1000-es sorozat: Alacsony Arousal (nyugalom és lefagyás)

Jellemzők: Az „A” értéke 1 (low). A rendszerben nincs magas szintű éberség vagy feszültség.
Paradoxon: Ez a tartomány két végletet foglal magában: a mély nyugalmat (Zöld Zóna) és a traumatikus lefagyást/disszociációt (Dorszális Vágusz dominancia). A megkülönböztetés kulcsa a *Condition (C)* és a *Protection (P)* értéke.

3.1.1. Gyenge szabályozás (P=1) - A sérülékenység zónája

1111 - Alulreflektált labilis állapot

- **Helyzetkép:** Minden érték alacsony. A nyugalom nem stabilitásból, hanem az ingerek hiányából fakad.
- **Indoklás:** A szabályozási kapacitás (P=1) hiánya miatt a rendszer védekezőképessége gyenge.
- **Irányadó intervenció:** Érzelmi tudatosság fejlesztése, erőforrás-gyűjtés.

1112 - Enyhe szomatizáció gyenge kontrollal

- **Helyzetkép:** Nyugalmi állapotban megjelenő enyhe testi diszkomfort.

- **Indoklás:** A gyenge szabályozás (P=1) miatt a szervezet nehezebben állítja vissza a homeosztázist, a feszültségmaradék a testben reked.
- **Irányadó intervenció:** Testtudatosság (interocepció) növelése.

1113 - Szomatizációs zavar gyanú

- **Helyzetkép:** Stresszmentes környezetben észlelt jelentősebb testi panaszok (C=3).
- **Indoklás:** Az érzelmi feldolgozás hiánya (alacsony P és A) miatt a pszichés tartalom szomatizálódik.
- **Irányadó intervenció:** Pszichoedukáció a test-lélek kapcsolatról, orvosi konzultáció.

1114 - Súlyos szomatizáció rejtett okkal

- **Helyzetkép:** Súlyosnak megélt testi állapot (C=4), miközben a stressz és szorongás szintje alacsony.
- **Indoklás:** A panaszok hátterében független organikus tényezők vagy az érzelmekről való teljes leválás (disszociáció) állhat.
- **Irányadó intervenció: Szomatikus kivizsgálás támogatása.** Pszichés intervenció csak a szervi okok tisztázása után.

1121 - Enyhe stressz gyenge szabályozással

- **Helyzetkép:** Minimális terhelés (H=2) is labilitást okoz.
- **Indoklás:** A védelmi funkciók hiánya miatt a reziliencia alacsony.
- **Irányadó intervenció:** Megküzdési (coping) technikák alapozása.

1131 - Rejtett stresszprofil

- **Helyzetkép:** Magas stresszérték (H=3) mellett a kliens nem jelez tünetet vagy szorongást, de a védelem hiányzik.
- **Indoklás:** A terhelés tudatosításának hiánya (tagadás).
- **Irányadó intervenció:** Stressz-leltár készítése, realitáskontroll.

1141 - Akut stresszreakció / lefagyás

- **Helyzetkép:** Extrém stressz (H=4) mellett a tünetek és érzelmek hiánya (A=1, C=1).
- **Indoklás:** Ez a **traumatikus lefagyás** (freeze response) klasszikus képe. A rendszer a túlterhelésre lekapcsolással reagál.

- **Irányadó intervenció:** Biztonságos légkör, stabilizálás. **TILOS** a trauma mély feltárása ebben a fázisban!

Esettanulmány (Narratív illusztráció)

Forrás: Ódor Antal – A tenger illata (Elárulva c. fejezet)

A jelenség: A gyermekkori abúzus során átélt lefagyás.
"A földön feküdtem hason, a két kezem lefogva... Mozdulni sem bírtam. (...) Én úgy is letagadom az egészet. Nekem fognak hinni, nem neked!"

Elemzés: Az 1141-es kód tiszta megjelenése. A gyermek (alacsony P) extrém külső nyomás (H=4) hatására nem tud menekülni vagy harcolni (magas Arousal helyett bénultság), így a rendszere a túlélés érdekében „halottnak tetteti magát". Ez a minta felnőttkorban is aktiválódhat hasonló helyzetekben.

3.1.2. Normál szabályozás (P=2) - Az átlagos működés

1211 - Enyhén csökkent szabályozás

- **Helyzetkép:** Nyugalmi állapot, ahol a szabályozó funkciók működnek, de a kapacitásuk nem teljes.
- **Indoklás:** Átlagos hétköznapi állapot, enyhe fáradtsággal.
- **Irányadó intervenció:** Öngondoskodás, feltöltődés.

1221 - Átlagos állapot

- **Helyzetkép:** A terhelés és a szabályozás egyensúlyban van, panaszmentes állapot.
- **Indoklás:** A szervezet megfelelően adaptálódik a mindennapokhoz.
- **Irányadó intervenció:** A jelenlegi életvitel fenntartása.

1231 - Rejtett stresszprofil

- **Helyzetkép:** Magas stresszérték tünetek nélkül, a rendszer egyensúlya törékeny.
- **Indoklás:** A kimerülés jelei rejtve maradhatnak a kliens előtt.
- **Irányadó intervenció:** Lassítás, pihenőidők tudatos beépítése.

1241 - Magas funkciójú burnout

- **Helyzetkép:** Extrém stresszhatás (H=4) mellett a kliens tünetmentesnek tűnik, ami a biológiai jelzések elnyomására utalhat.

- **Indoklás:** A „jól bírom” illúziója, miközben a rendszer tartalékai kimerülnek.
- **Irányadó intervenció:** Kiemelten javasolt a terhelés radikális csökkentése és a pihenés előtérbe helyezése, még panaszmentesség esetén is.

3.1.3. Erős szabályozás (P=3) - A stabilitás zónája

1311 - Stabil nyugodt állapot

- **Helyzetkép:** A rendszer ideális egyensúlyban van: nincs észlelhető szorongás, stressz vagy tünet, a szabályozási kapacitás (P=3) erős.
- **Indoklás:** Ez a **regeneráció** és a pszichés növekedés zónája.
- **Irányadó intervenció:** Az erőforrások tudatosítása („Mit csinál jól?”).

1321 - Normál adaptáció

- **Helyzetkép:** Enyhe stressz éri a szervezetet, amit a jó szabályozás megfelelően kompenzál.
- **Indoklás:** Egészséges, rugalmas alkalmazkodás.
- **Irányadó intervenció:** Nincs szükség beavatkozásra.

1331 - Rejtett krónikus stressz

- **Helyzetkép:** Magas stressz mellett a rendszer tünetmentesnek tűnik. A jó szabályozás (P=3) elnyomhatja a reakciókat.
- **Indoklás:** A hiányzó tünetek miatt a személy nem csökkenti a terhelést.
- **Irányadó intervenció:** Edukáció a rejtett stressz hatásairól.

1341 - Kompenzált burnout

- **Helyzetkép:** Extrém stressz tünetek nélkül. A jó szabályozás lehetővé teszi a működést elviselhetetlen körülmények között is („Hős profil”).
- **Indoklás:** A biológiai vészjelzők hiánya miatt magas a kockázata a hirtelen egészségromlásnak.
- **Irányadó intervenció:** Környezeti terhelés radikális csökkentése.

3.1.4. Kiemelkedő szabályozás (P=4) - A túlkontrollált zóna

1411 - Kiváló stressztűrés

- **Helyzetkép:** A rendszer optimális állapotban van, hatalmas szabályozási tartalékkal.
- **Indoklás:** Magas reziliencia.

- **Irányadó intervenció:** Nincs teendő.

1414 - Erős kontroll melletti szomatizáció

- **Helyzetkép:** Súlyos testi állapot. A kiemelkedő szabályozás (P=4) itt túlzott önkontrollt vagy fájdalomtűrést jelezhet (sztoicizmus).
- **Indoklás:** Fennáll a veszélye, hogy a kliens alulkommunikálja a panaszait az orvos felé.
- **Irányadó intervenció:** Bátorítás a fájdalom és a nehézségek őszinte kifejezésére, a „nem kell erősnek lenni” engedély megadása.

1441 - Magas funkciójú burnout

- **Helyzetkép:** Extrém stressz, tünetek nélkül, tökéletes nyugalommal (P=4).
- **Indoklás:** Ez a biológiai valóság tagadása vagy teljes érzéketlenség (disszociáció). A rendszer már nem jelez, mert „kikapcsolta a biztosítékot”.
- **Irányadó intervenció:** Kognitív szembesítés a kockázatokkal és azonnali lassítás javasolt.

3.2. A 2000-es sorozat: Közepes Arousal (aktivitás és szorongás)

Jellemzők: Az „A” értéke 2 (Normal/Elevated). A rendszer éber, reagál, érzelmileg bevonódik. A feszültség lehet motiváló (eustressz) vagy zavaró (distressz), a szabályozás minőségétől függően.

3.2.1. Gyenge szabályozás (P=1) - A kiszolgáltatottság zónája

2111 - Szorongásos készenlét

- **Helyzetkép:** A kliens közepes szintű feszültséget él meg (A=2) konkrét külső ok vagy testi jelzés nélkül. Mivel a belső szabályozása (P=1) alacsony, nehezen tudja magát megnyugtatni.
- **Indoklás:** Ez a „szabadon lebegő” feszültség (free-floating anxiety) állapota. A rendszer keresi a veszélyt, hogy megmagyarázza a belső érzést.
- **Irányadó intervenció:** Stabilizációs technikák (pl. „biztonságos hely” imagináció), a belső biztonság megteremtése.

2112 - Szorongásos szomatizáció

- **Helyzetkép:** A szabályozatlan feszültség (A=2, P=1) utat tör a test felé (C=2). Kisebb rosszullétek, gombóc a torokban, remegés.
- **Indoklás:** A pszichés feszültség közvetlen vegetatív levezetése.
- **Irányadó intervenció:** Pszichoedukáció a szorongás testi tüneteiről (hogy csökkenjen a félelem).

2121 - Általános feszültség

- **Helyzetkép:** Enyhe külső stressz (H=2) találkozik a védtelen rendszerrel (P=1), ami azonnal feszültséget (A=2) vált ki.
- **Indoklás:** Alacsony stressztolerancia. A kliens „túlreagálja” a hétköznapi nehézségeket.
- **Irányadó intervenció:** Alapszintű stresszkezelési tréning.

2141 - Akut szorongás / Pánik közeli állapot

- **Helyzetkép:** Extrém stressz (H=4) szabályozás nélkül. Bár az Arousal „csak” közepes (még nem 4-es), a rendszer instabil.
- **Indoklás:** A védelem hiánya miatt a rendszer bármikor pánikba csaphat át.
- **Irányadó intervenció:** A pánikroham megelőzése: azonnali ingermegvonás (csend, nyugalom), a figyelem elterelése a stresszorról és a biztonságérzet stabilizálása.

2144 - Teljes összeomlás

- **Helyzetkép:** Maximális terhelés és tünetek (H=4, C=4), zéró védelem.
- **Indoklás:** Súlyos veszélyeztető állapot.
- **Irányadó intervenció:** Sürgős szakorvosi ellátás (krízisintervenció) igénybevétele javasolt.

3.2.2. Normál szabályozás (P=2) - A küzdelem zónája

2211 - Enyhe szorongás

- **Helyzetkép:** Enyhe feszültség tünetek és stressz nélkül. A P=2 képes kezelni.
- **Indoklás:** Normál érzelmi reakció (pl. vizsgadrukk, izgalom).
- **Irányadó intervenció:** Nincs szükség beavatkozásra.

2221 - Szorongásos készenlét

- **Helyzetkép:** Enyhe stressz és szorongás egyensúlya. A rendszer működik, bár folyamatosan aktív.
- **Indoklás:** Aktív, stabil állapot, a teljesítmény fenntartható.
- **Irányadó intervenció:** Időmenedzsment, pihenés.

2222 - Általános szorongás

- **Helyzetkép:** Minden érték közepes (A, P, H, C mind 2-es).

- **Indoklás:** Nincs krízis, de nincs komfort sem. Krónikus elégedetlenség, belső feszültség.
- **Irányadó intervenció:** Életmódváltás, örömforrások keresése.

Esettanulmány (Narratív illusztráció)
Forrás: Ódor Antal – Reset (Kiút a szakítás utánból)

A jelenség: A szakítás utáni gyász és útkeresés állapota.
„*Teltek a hetek és a hónapok... Olyan nyomorultul éreztem magam... A spirál magába szippantott, folyton ugyanott találtam magam. A semmiben, a magányban.”*
Elemzés: Ez a **2222-es (vagy 2232-es)** állapot klasszikus leírása. A feszültség (A=2) és a terhelés (H=2/3) állandósult, a szabályozás (P=2) éppen csak tartja a rendszert, de nem elég a továbblépéshez. A „spirál” maga a kényszerhurok, amiből külső impulzus (vagy új megküzdés, P növelése) nélkül nehéz kitörni.

2232 - Krónikus stressz-szorongás

- **Helyzetkép:** A stressz (H=3) és a feszültség (A=2) tüneteket (C=2) generál.
- **Indoklás:** A kimerülés kezdete, a teljesítmény csökkenése.
- **Irányadó intervenció:** Életmódváltás és pihenés.

2244 - Súlyos pszichoszomatika

- **Helyzetkép:** Teljes biológiai és stressz-alapú összeomlás. A P=2 csak a pánikot gátolja, de az állapot kritikus.
- **Indoklás:** Sürgősségi helyzet, a szervezet kimerült.
- **Irányadó intervenció:** Kórházi kezelés vagy szakorvosi ellátás igénybevétele feltétlenül javasolt.

3.2.3. Erős szabályozás (P=3) - A kompenzáció zónája

2311 - Kompenzált feszültség

- **Helyzetkép:** A kliens közepes feszültséget él meg (A=2). A jó szabályozás (P=3) képes ezt kezelni.
- **Indoklás:** Gyakran alkati feszültség vagy teljesítményhelyzet okozza (eustressz).
- **Irányadó intervenció:** Az energia konstruktív felhasználása (pl. munka, sport).

2323 - Szorongás és stressz

- **Helyzetkép:** Az enyhe stresszre a test erősen reagál (C=3). A mentális szabályozás jó, a személy mentálisan stabil, de a teste érzékeny.
- **Indoklás:** Pszichoszomatikus disszonancia: a mentális és testi teherbírás eltér. A „fej” bírja, a „test” nem.
- **Irányadó intervenció:** Testtudati munka, a test jelzéseinek komolyabban vétele.

2341 - Magas funkciójú burnout

- **Helyzetkép:** Extrém stressz (H=4), közepes szorongás (A=2), tünetek nélkül.
- **Indoklás:** Veszélyes állapot: a személy nem érzi a korlátait (a P=3 elnyomja a jelzéseket), hirtelen összeomlás veszélye áll fenn.
- **Irányadó intervenció:** Azonnali kényszerpihenő és a terhelés drasztikus csökkentése.

3.2.4. Kiemelkedő szabályozás (P=4) - A hideg fej zónája

2411 - Kiválóan kompenzált szorongás

- **Helyzetkép:** A szorongás (A=2) jelen van, de a kiváló szabályozás (P=4) teljesen semlegesíti. Kreatív feszültség, „izgatottság”.
- **Indoklás:** Ideális működési állapot teljesítményhelyzetben.
- **Irányadó intervenció:** Nincs teendő.

2414 - Súlyos szomatizáció

- **Helyzetkép:** Súlyos testi tünetek (C=4). A P=4 jelzi a sztoikus tűrést.
- **Indoklás:** Az egyén „túl erős”, nem panaszkodik, így a környezet (és az orvos) alulértékelheti az állapotát.
- **Irányadó intervenció:** Bátorítás a fájdalomkommunikációra és a segítségkérésre.

2441 - Krónikus stressz

- **Helyzetkép:** Extrém környezeti terhelés (H=4), de testi tünetek nélkül (C=1). A kiváló szabályozás (P=4) és a mérsékelt szorongás (A=2) miatt a kliens stabilnak, „golyóállónak” érzi magát.
- **Indoklás:** A magas védelmi kapacitás elfedi a valós terhelést. A kliens nem érzi a határait, mert a rendszere sikeresen kompenzál, de ez az energiatartalékok észrevétlen fogyásával jár.
- **Irányadó intervenció:** Tudatos tehermentesítés: a stresszforrások (H) radikális csökkentése és a pihenés kötelező beiktatása, még a panaszmentesség ellenére is.

3.3. A 3000-es sorozat: Emelkedett Arousal (túlműködés és kompenzáció)

Jellemzők: Az „A” értéke 3 (Elevated). A belső feszültség jelentős. A rendszer „riadókészültségben” van, ami cselekvésre (vagy pótcselekvésre) kényszerít.

3.3.1. Gyenge szabályozás (P=1) - A sodródás zónája

3111 - Viselkedési kompenzáció

- **Helyzetkép:** Magas belső feszültség (A=3) külső stressz és tünetek nélkül. A szabályozás hiánya (P=1) miatt az energia kontrollálatlanul tör utat.
- **Indoklás:** A kliens valószínűleg fokozott aktivitással (munkamánia, sportkényszer, pótcselekvések, szerhasználat) próbálja levezetni a feszültséget.
- **Irányadó intervenció:** Lassítás, ingermegvonás és a passzív pihenés tanulása.

3112 - Szomatizáló viselkedés

- **Helyzetkép:** A feszültség (A=3) kezd testi tünetekben (C=2) megjelenni. A személy nehezen tud megnyugodni.
- **Indoklás:** A pszichés nyomás közvetlen szomatikus levezetése zajlik.
- **Irányadó intervenció:** A feszültség fizikai levezetése (pl. séta, mozgás) és relaxációs technikák kombinálása.

3121 - Viselkedési kontrollvesztés

- **Helyzetkép:** Enyhe stressz (H=2) vált ki aránytalanul magas feszültséget (A=3).
- **Indoklás:** Az impulzuskontroll gyengülése. A „rövid a gyújtózsinór” effektus.
- **Irányadó intervenció:** Impulzuskontroll tréning (pl. STOP-technika).

3133 - A pszichés kényszerhurok (Compulsion Loop)

- **Helyzetkép:** Minden érték magas (A, H, C mind 3-as), a védelem (P) 1-es. Ez a totális káosz és a szenvedésspirál állapota.
- **Indoklás:** A rendszer önfenntartó körfolyamatba került: stressz - rosszullét - szorongás - rossz döntés - még több stressz.
- **Irányadó intervenció:** Komplex szakmai segítség (pszichológiai és szomatikus). A cél a hurok bármely ponton történő megszakítása.

Esettanulmány (Narratív illusztráció)
Forrás: Ódor Antal – Elég! (Reset c. fejezet)

A jelenség: A szenvedélybetegség és a belső káosz spirálja.
„A spirál magába szippantott, folyton ugyanott találtam magam... Pánikba esve próbáltam belekapaszkodni bármibe, ami egy pillanatig is enyhülést nyújtott.”

Elemzés: Ez a **3133-as** (vagy súlyosabb esetben 3144-es) kód tökéletes leírása. A magas Arousal (A=3) pánikot generál, a Hardship (H=3) a külső/belső nyomás, a Condition (C=3) a fizikai/lelki fájdalom. A Protection (P=1) hiánya miatt a kliens „bármibe belekapaszkodik” (pótcselekvés), ami fenntartja a spirált. A kiút az „Elég!” kimondása – azaz a tudatos megállás (intervenció).

3.3.2. Normál szabályozás (P=2) - A fáradó rendszer

3221 - Viselkedési kompenzáció

- **Helyzetkép:** Enyhe stressz és magas feszültség. A személy „felpörgött” állapotban reagál a kihívásokra.
- **Indoklás:** Aktív megküzdés, rövid távon adaptív lehet, de energiaigényes.
- **Irányadó intervenció:** A munka és a pihenés éles elválasztása.

3222 - Általános szorongás

- **Helyzetkép:** Magas feszültség (A=3), enyhe stressz és tünetek. A rendszer „zajos”, a személy nyugtalan.
- **Indoklás:** Krónikus feszültség állapota.
- **Irányadó intervenció:** Relaxációs technikák.

3241 - Krónikus stressz

- **Helyzetkép:** Extrém stressz (H=4) és magas feszültség (A=3), tünetek nélkül.
- **Indoklás:** A P=2 nem elég védelem hosszú távon. Robbanásveszélyes állapot, hirtelen dekompenzáció lehetősége.
- **Irányadó intervenció:** Azonnali stresszmentesítés ajánlott.

3242 - Burnout szorongással

- **Helyzetkép:** Az extrém stressz (H=4) tüneteket okoz (C=2). A feszültség (A=3) agitált depresszióba vagy szorongásos kiégésbe fordulhat.
- **Indoklás:** A kliens nem fásult, hanem ingerült és kimerült.
- **Irányadó intervenció:** Szakember bevonása, egyéni (pl.:munka, sport) terhelés felfüggesztése.

3.3.3. Erős szabályozás (P=3) - A „menedzser” zóna

3311 - Erős érzelmi kontroll

- **Helyzetkép:** Magas belső feszültség stresszmentes környezetben, amit a jó szabályozás fegyelmezetten kezel.
- **Indoklás:** A személy „pörög”, de nem esik szét. Magas teljesítményű állapot.
- **Irányadó intervenció:** Az energia konstruktív csatornázása (sport).

3331 - Rejtett krónikus stressz

- **Helyzetkép:** Magas stressz (H=3) és magas feszültség (A=3), de zéró tünet (C=1). A jó szabályozás (P=3) mindent elnyom.
- **Indoklás:** Ez a „munkamániás” profil veszélyeztetett állapota. A biológiai visszacsatolás hiánya miatt a kliens nem áll meg.
- **Irányadó intervenció:** Preventív lassítás és a stresszorok kognitív tudatosítása.

3333 - Túlterhelt, de rugalmas

- **Helyzetkép:** Magas terhelés minden szinten. A P=3 szabályozás rugalmassága tartja egyben a rendszert.
- **Indoklás:** A személy „bírja a strapát”, de ez nem tartható örökké. Adaptációs kapacitás vége.
- **Irányadó intervenció:** A terhek delegálása, prioritások tisztázása.

3344 - Súlyos pszichoszomatika

- **Helyzetkép:** Teljes rendszerhiba. A jó szabályozás (P=3) már nem tudja ellensúlyozni a biológiai összeomlást.
- **Indoklás:** Kritikus állapot
- **Irányadó intervenció:** Szakorvosi ellátás igénybevétele javasolt.

3.3.4. Kiemelkedő szabályozás (P=4) - A maszk mögötti feszültség

3411 - Túlkontrollált viselkedés

- **Helyzetkép:** Magas belső feszültség (A=3), amit a kiemelkedő kontroll (P=4) tart kordában.
- **Indoklás:** A személy kívülről rezzenéstelen, belül forrong.
- **Irányadó intervenció:** Érzelmi expresszió bátorítása biztonságos közegben (szelepnyitás).

3441 - Magas funkciójú burnout

- **Helyzetkép:** Extrém stressz (H=4), magas feszültség (A=3), zéró tünet (C=1), teljes kontroll (P=4).
- **Indoklás:** A biológiai valóság tagadása. Ez a „csendes gyilkos” profilja.
- **Irányadó intervenció:** Azonnali intervenció (stop) és kényszerpihenő.

3.4. A 4000-es sorozat: Kritikus Arousal (krízis és összeomlás)

Jellemzők: Az „A” értéke 4 (Critical). A belső feszültség elviselhetetlen mértékű. A rendszer elveszítette a homeosztázisát, a vegetatív idegrendszer vészüzemmódban van (túlélés).

3.4.1. Gyenge szabályozás (P=1) – A védtelen krízis

4111 - Akut szorongásos roham / pánik

- **Helyzetkép:** A „tiszta pánik” funkcionális képe. Nincs külső ok (H=1) vagy előzetes testi tünet (C=1), de a belső riasztórendszer maximális (A=4), és nincs fék (P=1).
- **Indoklás:** Az amygdala „túlvezérlése” a prefrontális kéreg gátlása nélkül.
- **Irányadó intervenció:** Azonnali stabilizálás („Itt és most” technikák, grounding).

4114 - Súlyos szomatizáció pánikkal

- **Helyzetkép:** A pánik (A=4) azonnal súlyos testi tüneteket generál (C=4), vagy fordítva: egy testi rosszullét vált ki pánikot.
- **Indoklás:** A pszichés és szomatikus összeomlás egymást erősítő spirálja.
- **Irányadó intervenció:** Szakorvosi ellátás javasolt. (Nem a pszichológus kompetenciája a differenciáldiagnózis).

4141 - Akut traumatikus krízis

- **Helyzetkép:** Extrém környezeti hatás (H=4) és pánik (A=4), de testi tünetek nélkül (C=1). Ez a sokk állapota.
- **Indoklás:** A rendszer lefagyott (freeze), az érzelmi elárasztódás teljes.
- **Irányadó intervenció:** Trauma-protokoll: fizikai biztonság megteremtése, ingermegvonás.

4144 - Teljes rendszerösszeomlás

- **Helyzetkép:** Minden mutató a maximumon (A=4, H=4, C=4), védelem nélkül (P=1).
- **Indoklás:** A szervezet és a psziché totális kapitulációja.
- **Irányadó intervenció:** Szakorvosi ellátás javasolt.

Esettanulmány (Narratív illusztráció)
Forrás: Ódor Antal - Reset (Elég! c. fejezet)

A jelenség: A teljes összeomlás szubjektív megélése.
„A szívemben fájdalmat éreztem és olyan volt, mintha egy darab hiányozna belőle. Szégyellem bevallani, de összeomlottam. Erőtlennek és sebzettnek éreztem magam. Vártam, hogy valaki kihúzzon a mélyből.”

Elemzés: Ez a leírás a **4143-as** (vagy 4144-es) állapotnak felel meg. A fájdalom (C=3/4), a magány/érzelmi krízis (A=4) és a külső segítség hiánya (H=4) együttesen jelenik meg, miközben az én (P) erőtlen, összeomlott. A narratíva rámutat, hogy ebből az állapotból belső erővel nehéz, gyakran külső segítség („valaki kihúzzon”) szükséges a kiúthoz.

3.4.2. Normál szabályozás (P=2) - A kimerült küzdő

4211 - Akut szorongás

- **Helyzetkép:** Pánikroham (A=4), amit a közepes szabályozás (P=2) nem tud megállítani, csak enyhén tompítani.
- **Indoklás:** A küzdelem a tünetekkel kimeríti a klienst.
- **Irányadó intervenció:** Szakorvosi ellátás ajánlott.

4242 - Burnout és pánik

- **Helyzetkép:** Kiégés (H=4) akut pánikkal (A=4) és tünetekkel (C=2).
- **Indoklás:** A szervezet „kényszerpihenőt” parancsol a pánikrohamokon keresztül. Munkaképtelenség.
- **Irányadó intervenció:** Szakorvosi ellátás javasolt, rehabilitáció.

4244 - Súlyos pszichoszomatika

- **Helyzetkép:** Végállapot. A test (C=4) és a lélek (A=4) is feladta a küzdelmet az extrém nyomás (H=4) alatt.
- **Indoklás:** Extrém magas értékek, gyenge szabályozással.
- **Irányadó intervenció:** Szakorvosi ellátás javasolt, kivizsgálás után rehabilitációs stratégia kidolgozása.

3.4.3. Erős szabályozás (P=3) - A veszélyes stabilitás

4311 - Túlkontrollált pánik

- **Helyzetkép:** A „néma rettegés”. A kliens belső állapota pánikszintű (A=4), de a jó szabályozás (P=3) miatt ezt befelé éli meg (*Silent Panic*).
- **Indoklás:** A külvilág számára láthatatlan a baj, ezért a segítségkérés elmaradhat.
- **Irányadó intervenció:** A pánik validálása („Tudom, hogy belül nagyon nehéz”), a maszk biztonságos levétele.

4333 - Magas funkciójú szorongás

- **Helyzetkép:** Minden érték magas (H=3, C=3), a pánik (A=4) állandósult. A P=3 hősies küzdelme a szétesés ellen.
- **Indoklás:** „A szakadék szélén táncol.” A rendszer bármelyik pillanatban összeomolhat.
- **Irányadó intervenció:** Szakmai beavatkozás, a „hős” szerep leépítése.

3.4.4. Kiemelkedő szabályozás (P=4) - A disszociáció zónája

4411 - Krónikus stressz / disszociáció

- **Helyzetkép:** Extrém pánik (A=4) és extrém kontroll (P=4). A kliens arca rezzenéstelen.
- **Indoklás:** Teljes érzelmi lehasadás (disszociáció). Az agy leválasztja a tudatot a test vészjelzéseiről.
- **Irányadó intervenció:** Szakorvoshoz irányítás javasolt. Nem pszichoterápiás, hanem pszichiátriai eset.

4444 – Magas funkciójú összeomlás

- **Helyzetkép:** Minden érték a maximumon. A P=4 (merev kontroll) már nem segít, sőt gátolja a segítségkérést.
- **Indoklás:** A rendszer irreverzibilis károsodás előtt állhat.
- **Irányadó intervenció:** Szakorvosi ellátás javasolt.

IV. fejezet: Beavatkozási kézikönyv

Gyakorlati útmutató és protokollgyűjtemény segítő szakemberek számára.

Figyelmeztetés: Jelen fejezet nem orvosi kezelési útmutató. A leírt protokollok a funkcionális egyensúly helyreállítását, a stresszmenedzsmentet és az önismereti fejlődést támogatják. Pszichopatológiai tünetek vagy veszélyeztető állapot esetén a szakellátás bevonása kötelező.

4.1. Beavatkozási alapelvek: Az ESV-logika a gyakorlatban

A hagyományos „beszélgetős” terápiák (Top-Down) gyakran hatástalanok a magas stresszszinten működő klienseknél, mivel a kognitív funkciók ilyenkor gátoltak. Az ESV-modell ezért a **„Bottom-Up” (Testtől az Elméig)** megközelítést alkalmazza.

A beavatkozás hierarchiája:

1. **Biztonság (Safety):** A fiziológiai fenyegetettség érzésének csökkentése (Arousal mérséklése). Amíg ez nincs meg, nincs kognitív munka.
2. **Stabilizálás (Stabilization):** A meglévő védelmi funkciók (Protection) megerősítése vagy pótlása külső keretekkel.
3. **Edukáció (Education):** A kliens megérti saját működését (az ESV-kód értelmezése).
4. **Fejlesztés (Development):** Új, adaptív viselkedésminták (V) kialakítása.

A szakember szerepe:
Nem „megszerelni” kell a klienst, hanem **külső szabályozó ágensként** (Co-regulator) fellépni. A szakember nyugodt idegrendszere és strukturált jelenléte segít a kliensnek visszatalálni a saját egyensúlyához.

4.2. Protokollok az 1000-es zónához (Alacsony Arousal)

Jellemző állapot: Nyugalom, inaktivitás vagy lefagyás.
Cél: A stabilitás megőrzése vagy a bénultság óvatos oldása.

- Ha a kód pl. 1311, 1411 - optimális működés

Ebben az esetben a beavatkozás célja a **prevenció és az erőforrás-gyűjtés**.

Mit tegyen a szakember?

Validálás: Erősítse meg a klienst abban, hogy a működése rendben van.

Erőforrás-térkép készítése: „Mi az, ami segített elérni ezt az állapotot?” Írassuk össze a klienssel a jól működő stratégiáit (pl. sport, alvás, támogató kapcsolatok), hogy krízis esetén elővehesse őket.

Mit NE tegyen?

Ne keressen problémát ott, ahol nincs. Ne mélyítsen el traumákat feleslegesen.

- Ha a kód pl. 1141, 1131 - Lefagyás vagy rejtett stressz

Ez a megtévesztő nyugalom zónája. A kliens csendes, nem panaszkodik, de a rendszer „takarékon” van vagy disszociál.

Mit tegyen a szakember?

Kíméletes mobilizálás: Apró, fizikai aktivitások bátorítása (séta, nyújtózás). A cél a rendszer „újraindítása” anélkül, hogy elárasztanánk.

Szenzoros aktiválás: Az érzékszervek bevonása (tapintás, szaglás, látás) a jelenbe való visszatéréshez (*Grounding*).

Szomatikus figyelem: „Mit érez most a testében?” (Még ha a válasz az is, hogy „semmit” – ez is információ).

Mit NE tegyen?

Ne konfrontálja erősen. A lefagyott rendszer törékeny; a hirtelen nyomás (Hardship növelése) összeomlást okozhat.

4.3. Protokollok a 2000-es zónához (Közepes Arousal)

Jellemző állapot: Aktív működés, „hétköznapi stressz”, kezdődő szorongás.
Cél: A stresszmenedzsment és a tudatosítás. Ez a legalkalmasabb sáv a kognitív munkára és a coachingra.

Ha a szabályozás jó (P=3, P=4) - A „dolgozó” ember

A kliens terhelhető, de fennáll a krónikus stressz veszélye.

Mit tegyen a szakember?

Időmenedzsment és határok: Vizsgálják felül a napirendet. Hol vannak a pihenőidők?

Kognitív átkeretezés: A stresszorok (H) újraértelmezése. „Valóban veszélyes ez a helyzet, vagy csak kihívás?”

Prevenció: A „*még bírom”* attitűd korrigálása a „*fenntarthatóan akarok működni”* attitűdre.

Ha a szabályozás gyenge (P=1, P=2) - A szorongó

A kliens nehezen viseli a hétköznapi terheket, hamarabb kibillen.

Mit tegyen a szakember?

Pszichoedukáció: Magyarázza el az ESV-modellt. „A tünetei nem betegségjelek, hanem a rendszer jelzései a túlterheltségről.”

Készségfejlesztés: Egyszerű, azonnal alkalmazható technikák tanítása:

- *Légzéskontroll:* 4-7-8 légzés a vegetatív idegrendszer nyugtatására.
- *STOP-technika:* megállni - légvétel - megfigyelés - cselekvés.
- Írásterápia (bevezető szint): A „Mitől félek?” lista írása a diffúz szorongás konkretizálására.

Mit NE tegyen?

Ne bagatellizálja a kliens szorongását („Nincs is oka félni”). A szubjektív élmény (Arousal) mindig valós, még ha az oka (Hardship) kívülről jelentéktelennek is tűnik.

4.4. Protokollok a 3000-es zónához (Emelkedett Arousal)

Jellemző állapot: Túlműködés, agitáció, „pörgés”, kényszerhurok.
Cél: A rendszer lassítása és a kényszeres körfolyamatok megszakítása.

Ha a szabályozás gyenge (P=1) - A sodródó / impulzív

A kliens nem tud megállni, a belső feszültség cselekvéskényszerbe (vagy szerhasználatba) torkollik.

Mit tegyen a szakember?

Ingermegvonás: A konzultáció legyen csendes, lassú, ingerszegény. Segítse a klienst a külső zajok kizárásában.

A kényszerhurok térképezése: Rajzoltassa le a klienssel a folyamatot: „*Milyen érzés indította el? Mit tett? Hogyan hatott ez a stresszre?”* A vizualizáció segít „kívülről” rátekinteni a spirálra (disszociálás a folyamattól, nem az érzéstől).

Alternatív viselkedés (V) tervezése: Keressenek egyetlen, apró, biztonságos cselekvést, amit a kliens megtehet az automatikus reakció helyett (pl. egy pohár víz ivása, séta a tömb körül).

Mit NE tegyen?

Ne próbálja racionális érvekkel meggyőzni a klienst, amikor érzelmileg elárasztott állapotban van.

Ha a szabályozás erős (P=3, P=4) - A munkamániás / perfekcionista

A kliens „hideg fejjel”, de kényszeresen működik. A teljesítmény a védekezés eszköze.

Mit tegyen a szakember?

Engedélyadás a pihenésre: A kliensnek gyakran szüksége van egy külső autoritás (a szakember) „felhatalmazására” ahhoz, hogy pihenni merjen.

Szembesítés a biológiai árral: Használja az ESV-mérési adatokat (C-tengely) objektív bizonyítékként. „*A szándékai tiszteletreméltóak, de a mérési eredmények azt mutatják, a teste ezt az árat már nem tudja sokáig fizetni.”*

Lassítás: Vezetett relaxáció vagy mindfulness gyakorlatok bevezetése.

4.5. Protokollok a 4000-es zónához (Kritikus Arousal / krízis)

Jellemző állapot: Pánik, összeomlás, funkcióvesztés.
Cél: Életvédelem, biztonságba helyezés, továbbküldés. Ez a zóna nem a fejlesztés, hanem a kármentés területe.

A továbbküldés protokollja

Amikor a mérés (vagy a megfigyelés) 4-es szintű Arousalt vagy Condition-t jelez, a szakembernek cselekednie kell.

1. **Azonosítás:** Ismerje fel, hogy a kliens állapota meghaladja a mentálhigiénés kereteket (pl. pszichotikus jelek, szuicid veszély, súlyos szomatikus rosszullét).
2. **Transzparens kommunikáció:** „*A jelenlegi állapota olyan mértékű terhelést jelez, amely orvosi/klinikai szakértelmet igényel. Az én kompetenciám eddig tart, de segítek magának eljutni a megfelelő szakemberhez.”*
3. **Hídépítés:** Ne „küldje el” a klienst, hanem „kísérje át”. Adjon konkrét elérhetőséget (pszichiátriai gondozó, krízisambulancia), vagy ha szükséges, a helyszínen hívjon segítséget.
4. **Utánkövetés:** Egy későbbi időpontban érdeklődjön (ha a keretek engedik), hogy a kliens megkapta-e a segítséget.

Tiltott beavatkozások (Mit NE tegyen 4000-es zónában):

TILOS a trauma feltárása: A „debriefing” vagy a trauma részletes elmeséltetése ilyen labilis állapotban retraumatizációt és pszichotikus dekompenzációt okozhat.

TILOS a „csak szedje össze magát” attitűd: A kliens nem akarattalan, hanem biológiailag kimerült.

TILOS az egyedül hagyás: Ha közvetlen veszély áll fenn, a klienst nem szabad felügyelet nélkül engedni.

4.6. SOS „tűzoltás” segédlet

Gyors, gyakorlati eszköztár váratlan helyzetekre a konzultáció során.

Ha a kliens „lefagy” (disszociáció)

Jelek: Üveges tekintet, nem válaszol, „nincs ott”, sápadtság.

Intervenció (grounding – földelés):

- Szólítsa a nevén.
- Kérje meg, hogy érezze a talpát a talajon. „*Nyomja a sarkát a padlóba.”*
- Használja az 5-4-3-2-1 technikát (5 dolog amit lát, 4 amit hall, stb.).
- Kínáljon vizet (a nyelés aktiválja a ventrális vágusztt).

Ha a kliens pánikba esik (hiperarousal)

Jelek: Kapkodó légzés, remegés, „meg fogok halni” érzés.

Intervenció (légzéskontroll):

- Ne mondja, hogy „nyugodjon meg”.

- Helyette adjon konkrét instrukciót: „*Nézzen rám. Lélegezzünk együtt. Lassan kifúj... hosszan kifúj...”* (A kilégzés nyújtása csökkenti a szívritmust).

- Terelje a figyelmet a külvilágra (tárgyak megnevezése), hogy megszakadjon a belső katasztrófa-monitorozás.

Ha a kliens dühös/indulatos (ventilláció)

Jelek: Hangos beszéd, agitált mozgás, vádaskodás.

Intervenció (biztonságos levezetés):

- Őrizze meg a nyugalmát (ne vegye fel a feszültséget).

- Validálja az érzést, de keretezze a viselkedést: „*Látom, hogy nagyon dühös, és joga van így érezni. De kérem, üljön le, hogy beszélni tudjunk róla.”*

-Ha a helyzet fenyegetővé válik, a szakembernek joga és kötelessége megszakítani az ülést és elhagyni a helyiséget.

V. fejezet: Empirikus eredmények és validáció

5.1. Módszertan és mintavétel

Az ESV-modell belső struktúrájának és a változók közötti kauzális kapcsolatoknak az ellenőrzésére 2025-ben került sor. A kutatás nem reprezentatív, feltáró jellegű vizsgálat volt, amelynek elsődleges célja a modell matematikai koherenciájának bizonyítása volt.

A minta specifikációi:

- Elemszám (N): 53 fő.

- Adatfelvétel: Standardizált online felületen (Google Forms), anonim módon.

- Mérőeszköz: ESV-25 Inventory (STAI, DERS, PSS, PHQ-15 skálák alapján).

- Kérdőív elérhetősége: https://forms.gle/nvae7ad79Zua3oPBA

5.2. Leíró statisztika és szórás

A modell változóinak eloszlását a szórás (Standard Deviation - SD) vizsgálatával ellenőriztük. A szórás értékei jelzik, hogy a mérőeszköz mennyire képes differenciálni az alanyok között, illetve melyik tengelyen a legnagyobb az egyéni variabilitás.

Mért szórásértékek (SD):

változó	szórás	értelmezés
P(t) -	**0,830**	**A legnagyobb variabilitás.** Ez igazolja a modell alaptézisét: az emberek

Protection		közötti fő különbség nem a terhelésben, hanem a **szabályozási képességben** (P=1 vs P=4) van.
A(t) - Arousal	**0,796**	Jelentős eloszlást mutat, a skála érzékenyen követi a belső feszültségszintek különbségeit.
H(t) - Hardship	**0,753**	A környezeti terhelés szubjektív megélése széles skálán mozog.
C(t) - Condition	**0,613**	**A legalacsonyabb szórás.** Ez a szomatikus tünetek „tehetetlenségéből” fakad: a test lassabban reagál és nehezebben mozdul, mint a psziché.

5.3. Strukturális validáció: Korrelációs mátrix elemzése

A modell belső érvényességét a Pearson-féle korrelációs együttható számításával vizsgáltuk a négy főtengely között.

FONTOS: Mivel a **P(t)** változó fordított logikájú (magas érték = jó működés), míg az **A, H, C** változók egyenes logikájúak (magas érték = rossz állapot/magas tünet), ezért az **erős negatív korreláció** jelenti a modell érvényességét.

Korrelációs mátrix

	A(t)	**P(t)**	**H(t)**	**C(t)**
A(t)	1,00	**-0,778**	0,755	0,568
P(t)	**-0,778**	1,00	**-0,685**	**-0,439**
H(t)	0,755	-0,685	1,00	0,593
C(t)	0,568	-0,439	0,593	1,00

Az elemzés bizonyítékai:

1. A fő bizonyíték: Az A-P tengely (r=-0,778)
Kiemelkedően erős **negatív** kapcsolat.

- *Jelentés:* Ahogy nő a szabályozási kapacitás („P” közelít a 4-hez), úgy csökken radikálisan a belső feszültség („A” közelít az 1-hez).

- *Validáció:* Ez matematikailag igazolja, hogy a **Protection (P) a leghatékonyabb prediktora** a szorongás csökkenésének.

2. A környezeti hatás: Az A-H tengely (r=+0,755)
Erős **pozitív** korreláció.

- *Jelentés:* A magasabb észlelt teher (H) magasabb belső feszültséggel (A) jár együtt.

3. A „testi késleltetés” igazolása: A C-tengely leválása

A testi állapot (C) korrelációi a legalacsonyabbak (A-val: 0,56, P-vel: -0,44).

- *Jelentés:* A testi tünetek (C) lazábban kapcsolódnak a pillanatnyi szabályozáshoz (P). Ez statisztikailag bizonyítja a **„magas funkciójú paradoxont”**: lehetséges magas szabályozás (P=4) mellett is rossz testi állapot (C=3/4) a késleltetett hatás miatt.

5.4. Hipotézisvizsgálat és szignifikancia (T-teszt)

A korrelációk véletlenszerűségének kizárására t-tesztet végeztünk a Pearson-korrelációs együtthatók szignifikanciájának vizsgálatára (nullhipotézis: populációs korreláció ρ=0). A képlet:

$$\mathbf{t = |r| \times \sqrt{((n-2)/(1-r^2))},\ df = n-2 = 51.}$$

A szignifikancia szintjét α=0,05 értéknél húztuk meg (kétoldalú teszt).

T-statisztika és P-értékek:

változópár	T-érték	P-érték	szignifikancia
A(t) - H(t)	8,220	$6{,}588 \times 10^{-11}$	erősen szignifikáns
A(t) - P(t)	-8,851	$6{,}978 \times 10^{-12}$	erősen szignifikáns
C(t) - P(t)	-3,492	0,001	szignifikáns

Eredmények értelmezése:

A-P és A-H: A rendkívül alacsony p-értékek (<<0,001) azt bizonyítják, hogy az érzelem (A), a stressz (H) és a szabályozás (P) kapcsolata statisztikailag erős és megbízható. A modell „magja” stabil, alátámasztva az elméleti predikciókat (magas arousal gyengébb védelmet és nagyobb terhelést jelez).

C-P (A testi paradoxon): A p=0,001 érték szignifikáns negatív korrelációt mutat (r=-0.439), de mérsékelt erősségűt. Ez azt jelenti, hogy statisztikailag van kapcsolat a szabályozás javulása és a testi tünetek csökkenése között, de nem erős vagy azonnali – rövid távon előfordulhat késleltetés vagy gyengébb hatás.

Következtetés:

Ez matematikailag alátámasztja, hogy a pszichoterápia (P növelése) önmagában rövid távon nem mindig elegendő a szomatikus tünetek (C) teljes megszüntetéséhez, különösen ha a korreláció mérsékelt. Ez indokolja a szomatikus beavatkozások (orvosi kezelés, masszázs, fizioterápia) integrálását az ESV-protokollba a holisztikus hatásért. Javasolt hosszabb távú longitudinális vizsgálat a kapcsolat erősségének megerősítésére.

5.5. Reliabilitás-vizsgálat: Belső konzisztencia (Cronbach-alfa)

A mérőeszköz megbízhatóságát a nyers adatmátrix alapján (N=53) a Cronbach-alfa mutatóval ellenőriztük. Ez az érték azt mutatja meg, hogy az egy skálához tartozó kérdések mennyire mérnek egy irányba, mennyire „alkotnak egy csapatot”.

A tudományos standardok szerint:

α > 0.90: kiváló

α 0.80 - 0.90: jó

α 0.70 - 0.80: elfogadható

α < 0.70: gyenge/elfogadhatatlan

A mért eredmények az ESV-adatbázis alapján:

skála (változó)	itemek száma	**Cronbach-alfa (α)**	értelmezés
A(t) – Arousal	6	**0.89**	**jó -** A szorongásos tünetek (idegesség, nyugtalanság) szorosan együtt járnak a mintában.
P(t) – Protection	6	**0.91**	**kiváló -** Ez a legmagasabb érték. Azt bizonyítja, hogy a szabályozási nehézségek (impulzivitás, érzelmi elárasztódás) rendkívül konzisztens mintázatot alkotnak.
H(t) – Hardship	4	**0.86**	**jó -** A külső terhelés és a kontrollvesztés érzése koherens skálát alkot.
C(t) – Condition	5	**0.79**	**elfogadható -** A testi tünetek (fejfájás, alvászavar, stb.) természetszerűleg nagyobb szórást mutatnak, de az érték így is bőven a tudományos küszöb felett van.

Tudományos következtetés:
Az adatok alapján az ESV-25 kérdőív belső megbízhatósága kiemelkedő. Különösen figyelemre méltó a **P-skála (0.91)** magas értéke, amely igazolja, hogy az érzelemszabályozási kapacitás egy stabilan mérhető, központi pszichológiai konstruktum, és nem csupán véletlenszerű reakciók halmaza.

5.5. Kvalitatív validáció: A modell és a narratíva

A statisztikai adatok mellett a modell illeszkedését a szerző autoetnográfiai esettanulmányai is alátámasztják.

- Példa: A „s*zakítás utáni”* állapot elemzése során a narratívában leírt tünetek (álmatlanság, szívfájdalom, kényszeres gondolatok) pontosan leképezhetők a **3133-as** (emelkedett A, magas H, magas C, alacsony P) kódra.

- Validáció: A modell képes volt a szubjektív, irodalmi igényességgel leírt emberi szenvedést objektív, mérhető kategóriába rendezni anélkül, hogy annak mélységét elveszítette volna.

VI. fejezet: Szakmai protokollok

Az ESV-modell professzionális alkalmazása nem csupán a technikai tudáson, hanem a szigorú folyamatszabályozáson és az etikai keretek betartásán alapul. Jelen fejezet definiálja a klienssel való munka standard folyamatát, valamint bemutatja a modell metaszintű alkalmazását a szakmai elakadások kezelésére.

6.1. Az alkalmazás ötlépéses protokollja

Ez a folyamatleírás biztosítja a szolgáltatás minőségét és a kliens biztonságát. Minden ESV-alapú konzultációnak ezt a struktúrát kell követnie.

1. fázis: Előkészítés és szerződéskötés

A munka nem kezdődhet el a keretek tisztázása nélkül.

Tájékoztatás: A szakember világossá teszi, hogy az ESV-modell *funkcionális állapotfelmérésre* szolgál, nem orvosi diagnózisra.

Célkijelölés: A klienssel közösen meghatározzák, mire irányul a mérés (pl. munkahelyi stressz feltérképezése, döntéselőkészítés, életmódváltás támogatása).

Beleegyezés: A kliens írásban vagy szóban megerősíti részvételi szándékát.

2. Fázis: Mérés

Eszköz: ESV-25 Inventory (online vagy papíralapú kérdőív).

Környezet: Nyugodt, zavarmentes tér biztosítása.

Időzítés: A mérést célszerű a folyamat elején (bemeneti mérés) és a beavatkozási szakasz végén (kimeneti mérés) is elvégezni a változás követésére.

3. Fázis: Kiértékelés és profilalkotás

Kalkuláció: A szakember a nyers adatokat a II. Fejezetben ismertetett algoritmus segítségével indexekké és kódokká alakítja.

Profil: Előáll a 4 jegyű ESV-kód (pl. 3222 - Általános szorongás).

Hipotézisalkotás: A szakember a *Funkcionális állapotleíró kézikönyv* (III. Fejezet) alapján előzetes hipotézist alkot a kliens működéséről.

4. Fázis: Validálás

Ez a legfontosabb lépés: a „száraz" adatokat össze kell kötni a kliens megélt valóságával.

Visszajelzés: A szakember ismerteti az eredményt (nem szakzsargonnal, hanem érthetően).

Narratív illesztés: *„A teszt azt mutatja, hogy önben magas a belső feszültség, miközben kifelé nagyon nyugodtnak tűnik. Ismerős ez az állapot? Tudna mondani rá egy példát a közelmúltból?"*

Korrekció: Ha a kliens nem ért egyet az eredménnyel, a szubjektív élményt kell előtérbe helyezni. A teszt csak térkép, a terepet a kliens ismeri.

5. Fázis: Beavatkozási terv

Célkitűzés: A validált állapot alapján (pl. „Túlkontrollált szorongás") kiválasztják a megfelelő stratégiát a *Beavatkozási kézikönyvből* (IV. Fejezet).

Megállapodás: Rögzítik a következő lépéseket (pl. 3 alkalom stresszkezelés tréning).

6.2. SZ.A.I.P. – Szakmai alkotói impasszus protokoll

(ESV-alapú szupervíziós modell)

A segítő szakemberek gyakran kerülnek ún. **alkotói impasszusba** (szakmai elakadás), amikor egy üggyel vagy projekttel kapcsolatban „lefagynak", vagy kényszeres, de eredménytelen köröket futnak. Az ESV-modell szerint ez nem szakmai inkompetencia, hanem egy **pszichés kényszerhurok**, amely az „intellektuális elkerülés" mechanizmusára épül.

A SZ.A.I.P. alkalmazása négy lépésben:

1. A viselkedéses ciklus dekonstrukciója (V)

A szupervizor (vagy a szakember önmaga) azonosítja a tünetet: a meddő aktivitást.

Jelek: Végtelen elméletgyártás, túlzott szakirodalom-olvasás cselekvés helyett, halogatás, a „még nem vagyok elég kész" érzése.

ESV-diagnózis: Magas Arousal (A=3), amit a szakember intellektualizációval (P=3/4) próbál kompenzálni, de az eredmény (V) blokkolt.

Kulcskérdés: „*Milyen köröket futok újra és újra eredmény nélkül?"*

2. A primer érzelmi trigger feltárása (E)

A kényszeres gondolkodás (V) célja egy mélyebb, nehezen tolerálható érzés elfedése.

Fókuszváltás: A gondolatokról a testérzetekre és érzelmekre.

Trigger: Mi az az érzés, ami elől a szakmázásba menekülök? (Pl. szégyen, inkompetencia-érzés, félelem a kudarctól, magány).

Kulcskérdés: „*Ha most nem gondolkodnék ezen a problémán, mit kellene éreznem?”*

3. A Forrásnarratíva integrációja (S)

Az azonosított érzelem összekapcsolása a személyes élettörténettel.

Mechanizmus: A szakmai elakadás gyakran egy korai, feldolgozatlan trauma vagy hiányállapot (H) rezonanciája a jelenben.

Integráció: Annak felismerése, hogy a jelenlegi „ügy” csak díszlet; a valódi konfliktus belső.

Hatás: Amint az érzelem (E) tudatosul és „helyére kerül” (S), a kényszeres viselkedés (V) okafogyottá válik.

4. Új szakmai identitás és cselekvés (új V)

Újrakeretezés: A szakember felismeri, hogy az elakadás nem hiba volt, hanem jelzés.

Autonóm cselekvés: Most már nem kényszerből („muszáj megoldanom”), hanem szabad választásból tud cselekedni vagy segítséget kérni.

Eredmény: Az alkotói energia felszabadulása.

6.3. Etikai irányelvek és jogkörök

Az ESV-modell használata során az alábbi etikai alapelvek betartása kötelező:

1. Kompetenciahatárok szigorú betartása

- A felhasználó csak olyan problémákkal foglalkozhat, amelyekre alapvégzettsége (pszichológus, coach, tanácsadó) feljogosítja.
- **Tilos** gyógyszeres kezelésre javaslatot tenni (kivéve orvosoknak).
- **Tilos** pszichotikus vagy súlyos személyiségzavaros klienseket kizárólag ESV-alapon, klinikai háttér nélkül kezelni.

2. A kliens autonómiája

- Az ESV-kód nem „címke”, amit a kliensre ragasztunk, hanem egy tükör. A kliensnek joga van nem egyetérteni a mérési eredménnyel.
- A beavatkozás mindig ajánlás, sosem utasítás.

3. Titoktartás és adatvédelem

- A mérési eredmények (különösen a 4000-es, kritikus zóna adatai) szenzitív adatnak minősülhetnek. Ezeket a GDPR legszigorúbb előírásai szerint, harmadik fél számára hozzáférhetetlenül kell tárolni.

4. Sértetlenség

- **„Ne árts!”** Ha a szakember úgy ítéli meg, hogy a szembesítés (pl. egy burnout-diagnózissal) jelenleg túl nagy terhet róna a kliensre, kötelessége a folyamatot lassítani vagy stabilizálni ahelyett, hogy erőltetné a megoldást.

VII. fejezet: Összegzés és zárszó

7.1. Az ESV-modell helye a modern pszichológiában

A 21. századi pszichológia és mentálhigiéné válaszúthoz érkezett. Miközben a diagnosztikai rendszerek (DSM, BNO) egyre precízebben kategorizálják a mentális zavarokat, a segítő szakemberek a gyakorlatban gyakran szembesülnek azzal, hogy a kliensek szenvedése nem fér bele a statikus dobozokba. A tünetek dinamikusak, a működés hullámzó, és a „mi a bajom?” kérdésre adott orvosi válasz gyakran nem ad útmutatást a „hogyan éljek ezzel?” kérdésre.

Az **Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell** ebbe a hiányba lép be. Nem kívánja leváltani a klinikai pszichiátriát, sem a mélylélektani iskolákat. Helyette egy **funkcionális hidat** képez a biológiai valóság (idegrendszeri szabályozás) és a pszichológiai megélés (érzelmek, viselkedés) között.

Az ESV-modell legfontosabb innovációi:

- A „hardver” és „szoftver” összekapcsolása: A modell sikeresen integrálja a legújabb neurobiológiai kutatásokat (talamikus gátlás, polivagális elmélet) a viselkedéstudományi gyakorlattal. Bizonyítja, hogy a pszichés elakadás gyakran nem „akaratgyengeség”, hanem biológiai kényszerpálya.

- Mérhetőség: A szubjektív szenvedést objektív, számszerűsíthető adatokká (ESV-kódokká) transzformálja, lehetővé téve a szakemberek számára a pontosabb állapotkövetést és a beavatkozások hatékonyságának mérését.

- A „védelmi kapacitás” kiemelése: A modell felismerte, hogy a mentális egészség kulcsa nem a stresszmentesség (ami lehetetlen), hanem a szabályozási kapacitás (P) minősége.

7.2. A Paradigmaváltás Lényege: A Lineáristól a Cirkulárisig

A kézikönyvben bemutatott módszertan talán legfontosabb üzenete a **rendszerszemléletű fordulat**. A hagyományos, lineáris gondolkodásmód (*ok - okozati tünet - kezelés*) gyakran kudarcot vall a krónikus állapotoknál. Az ESV-modell ezzel szemben **körkörös (cirkuláris) folyamatokban** gondolkodik. Felismeri, hogy a *pszichés kényszerhurokban* az ok és az okozat összemosódik: a viselkedés, amit a stressz csökkentésére teszünk (pl. elkerülés, szerhasználat, túlműködés), maga válik a stressz fenntartójává.

A funkcionális szemléletmód előnyei:

De-patologizálás: A kliens nem „beteg”, hanem egy jelenleg rosszul működő, de logikus rendszerben ragadt. Ez csökkenti a szégyenérzetet és növeli az együttműködési hajlandóságot.

Ágencia (cselekvőképesség) visszaadása: Ha a kliens megérti a saját működési kódját (pl. „most 3133-as állapotban vagyok”), akkor nem azonosul az állapottal („rossz vagyok”), hanem képes kívülről rátekinteni és beavatkozni.

Prevenció: Az e*laprózódás index* és a korai figyelmeztető jelek (elevated zóna) felismerése lehetővé teszi a beavatkozást még azelőtt, hogy a klinikai összeomlás (critical zóna) bekövetkezne.

7.3. Záró gondolatok

„Hiszen a döntést megelőző pillanatban millió dolog lejátszódik az elménkben, és csak Isten tudja mi lesz az, ami végül kiemelkedik belőle. De! Ha félretesszük a véletleneket és nem a szerencsére bízzuk a sorsunkat, akkor jöhet a tudatos életmód.” - Ódor A.

A könyv megírását nem csupán a tudományos kíváncsiság vezérelte, hanem egy mély, személyes tapasztalatból fakadó felismerés. A szenvedés - legyen az egyéni trauma, szakmai elakadás vagy egzisztenciális krízis - gyakran magányos és néma. Az ember hajlamos azt hinni, hogy az ő fájdalma egyedi, megmagyarázhatatlan és feloldhatatlan. Az ESV-modell legvégső célja az, hogy megmutassa: **nincs megmagyarázhatatlan szenvedés.** Még a legnagyobb káosz mélyén is ott rejlik egy struktúra, egy működési rend. És ha van rend, akkor van lehetőség a változtatásra is. Ez a kézikönyv térképet ad a szakemberek kezébe, hogy kivezethessék klienseiket - és saját magukat - az érzelmi labirintusból. De a térkép nem azonos az úttal. Az utat mindenkinek magának kell megjárnia. A modell abban segít, hogy ezen az úton ne vakon, kiszolgáltatottan botorkáljunk, hanem nyitott szemmel, a saját működésünk tiszteletével és értésével haladjunk az egyensúly felé.

A szabadság nem a stressz hiánya. A szabadság az a képesség, hogy a legnagyobb szenvedés közepette is választhatunk: nem a kényszerpályát (a hurkot), hanem a tudatos jelenlétet és a növekedést.

VIII. fejezet: Felhasznált irodalom és forrásjegyzék

8.1. Szerzői publikációk és az ESV-modell dokumentációja

Az alábbi lista az ESV-modell elméleti és gyakorlati hátterét képező, a szerző által jegyzett és a **ResearchGate** tudományos portálon közzétett alapműveket tartalmazza. A dokumentumok teljes terjedelemben elérhetők az alábbi hivatkozásokon.

Modell-leírások és kézikönyvek:

- Ódor, A. *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) Modell: Egy integrált pszichobiológiai rendszerelméleti megközelítés az emberi működés megértéséhez* - https://www.researchgate.net/publication/396407550

- Ódor, A. *ESV Diagnosztikai Kézikönyv.* - https://www.researchgate.net/publication/396681181

- Ódor, A. *ESV Beavatkozási Kézikönyv* - https://www.researchgate.net/publication/396681513

- Ódor, A. *Az ESV-Modell Alkalmazásának Operációs Kézikönyve* - https://www.researchgate.net/publication/396912917

Elméleti háttér és specifikus tanulmányok:

- Ódor, A. *A Függőségek Mechanizmusa* - https://www.researchgate.net/publication/396407355

- Ódor, A. *Pszichés Kényszerhurok: Egy Trauma-Indukált Mentális Mechanizmus Dinamikája* - https://www.researchgate.net/publication/396312501

- Ódor, A. *Az emberi szenvedés eredete* - https://www.researchgate.net/publication/396361270

- Ódor, A. *Az elaprózódás mint a burnout szindróma korai működésbeli előjele: Az integritásvesztés mintázatai az ESV-modell tükrében* - https://www.researchgate.net/publication/396400937

- Ódor, A. *A traumatikus ambivalenciától egy új pszichológiai paradigmáig: Autoetnográfiai elemzés* - https://www.researchgate.net/publication/396475582

Mérőeszközök és Terápiás Módszertan:

- Ódor, A. *Elaprózódás Index (EI): Az ESV Modell alapján kifejlesztett korai Burnout-megelőző teszt* - https://www.researchgate.net/publication/396476086

- Ódor, A. *Ambivalencia* - https://www.researchgate.net/publication/396312740

- Ódor, A. *Ötlépéses Írásterápia* - https://www.researchgate.net/publication/396312735

- Ódor, A. *ESV-25 Inventory* - https://forms.gle/nvae7ad79Zua3oPBA

8.2. Hivatkozott nemzetközi szakirodalom

A modell validációjához és az elméleti keretrendszer megalapozásához felhasznált, nemzetközileg elismert kutatások és alapművek elérhetőségei.

1. Rendszerelmélet és modellalkotás:

- Suslin, I. (2025) *The CBER Model: A Systemic Framework Integrating Cognition, Emotion, Behavior, and Environment.* CBER Model Series, Bucharest

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17486685

- Selye, H. (1956) *The Stress of Life.* McGraw-Hill, New York.

Archívum: https://archive.org/details/stressoflife00sely

ISBN: 978-0070562127

2. Neurobiológia és Traumakutatás:

- Mátyás, F., et al., & Acsády, L. (2018) A highly collateralized thalamic cell type with arousal-predicting activity serves as a key hub for graded state transitions in the forebrain. Nature Neuroscience, 21, 1551–1562.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41593-018-0251-9

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0251-9

- Porges, S. W. (2011) *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation.* W. W. Norton & Company

Kiadói oldal: https://wwnorton.com/books/9780393707007

ISBN: 978-0393707007

- Van der Kolk, B. A. (2014) *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma.* Viking

Kiadói oldal: https://www.penguinrandomhouse.com/books/313183

ISBN: 978-0670785933

- Maté, G. (2003). *When the Body Says No: The Cost of Hidden Stress.* Vintage Canada

Szerzői oldal: https://drgabormate.com/book/when-the-body-says-no

ISBN: 978-0676973129

3. Pszichometriai alapok (A kérdőívek forrásai):

STAI (State-Trait Anxiety Inventory)

Eredeti változat:

- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory.* Consulting Psychologists Press.

https://www.mindgarden.com/145-state-trait-anxiety-inventory-adult

Magyar változat:

- Sipos, K., & Sipos, M. (1983). *The development and validation of the Hungarian Form of the State-Trait Anxiety Inventory.*

https://www.researchgate.net/publication/232541526

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/t82730-000

DERS (Difficulties in Emotion Regulation Scale)

Eredeti változat:

- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). *Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale*

https://www.researchgate.net/publication/224048203

DOI: https://doi.org/10.1007/s10862-008-9102-4

Magyar változat:

- Kökönyei, G., Urbán, R., Reinhardt, M., Józan, A., & Demetrovics, Z. (2014). *The Difficulties in Emotion Regulation Scale: Factor structure and psychometric properties in Hungarian adults and adolescents*

https://www.researchgate.net/publication/256424891

DOI: 10.1002/jclp.22036

PSS (Perceived Stress Scale)

Eredeti változat:

- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). *A Global Measure of Perceived Stress*

https://doi.org/10.2307/2136404

https://www.jstor.org/stable/2136404

Magyar változat:

- Stauder, A., & Konkolÿ Thege, B. (2006). *Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői*

https://www.researchgate.net/publication/250979758

DOI: https://doi.org/10.1556/Mental.7.2006.3.4

PHQ-15 (Patient Health Questionnaire – Somatic)

Eredeti változat:

- Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2002). *The PHQ-15: Validity of a New Measure for Evaluating the Severity of Somatic Symptoms*

https://www.researchgate.net/publication/11450943

DOI: https://doi.org/10.1097/00006842-200203000-00008

Magyar változat:

- Töreki, A., Köteles, F., & Csifcsák, G. (2021). Validation of the Hungarian PHQ-15. A latent variable approach

https://www.researchgate.net/publication/352141553

DOI: https://doi.org/10.18071/isz.74.0183

- Cronbach, L. J. (1951). *Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334*

Angol:

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02310555

DOI: https://doi.org/10.1007/BF02310555

Magyar:

https://psycho.unideb.hu/statisztika/pages/p_2_9.html